Buổi 8 (CÔNG BỐ): Phiếu bài tập

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng · Cấp độ 1 · Neudata · *#ClearDataClearImpact* · Tuần 8 · Thứ Bảy 19/12/2026 · trực tuyến, 19:30–22:30

Họ và tên: _____ **Khoa/Phòng:** _____

Gõ câu trả lời vào tệp Word này hoặc in bản PDF.

Phần	Nhiệm vụ	Khi nào
A	Bài tập viết: sửa spin, bậc thang động từ, câu kết quả, tên đề tài từ PICO của bạn	Bài về nhà
B	**Thực hành bản thảo 2**: kiểm tra và hoàn thiện phần Kết quả cho câu hỏi của riêng bạn, và viết tên bài	Sau phần 8.1. Gửi email phần Kết quả trước 23:59 Chủ nhật 20/12
C	Công bố: nhận diện tạp chí săn mồi, phản hồi ý kiến phản biện	Bài về nhà
D	**Làm người phản biện**: thẩm định Bài báo 1 và Bài báo 2 bằng phiếu trả lời	Phần 8.3, hoàn thành ở nhà

Các tệp bạn cần (gửi qua email): bản PDF gốc của Bài báo 1 (Boulet 2024) và Bài báo 2 (Hyun 2023), bản nháp phần Kết quả của bạn từ Buổi 7 và gói kết quả của bạn.

Phần A: Bài tập viết (bài về nhà)

Nhiệm vụ. Tự làm bốn bài tập ở nhà và ghi câu trả lời vào chỗ trống. Đáp án có trong phiếu đáp án, gửi sau buổi học.

A1. Sửa spin

Viết lại mỗi câu sao cho câu chỉ nói điều mà dữ liệu và thiết kế cho phép.

#	Câu gốc (từ các bài báo)	Câu bạn viết lại
a	Bài báo 1 (tr.10), kết cục chính p = 0.42, hiệu số 13.2 ml/kg (khoảng tin cậy 95% −15.2 đến 41.6): tác giả dựa vào "the non-significant trend in fluid balance reduction" (xu hướng giảm cân bằng dịch không có ý nghĩa thống kê) để đề xuất một thử nghiệm lớn hơn.	
b	Bài báo 2 (tr.4): "a positive fluid balance on the first ICU day did not impact the 28-day mortality" (cân bằng dịch dương trong ngày ICU đầu tiên không tác động đến tử vong 28 ngày).	
c	Bài báo 2 (tiêu đề): "Impact of a cumulative positive fluid balance during the first three ICU days in patients with sepsis …" (Tác động của cân bằng dịch tích lũy dương trong ba ngày ICU đầu tiên ở người bệnh sepsis …)	
d	Bài báo 1 (tr.10): quy trình đạt được "the lowest fluid balance on Day 5 ever published" (cân bằng dịch ngày 5 thấp nhất từng được công bố).	

A2. Leo bậc thang động từ

Với mỗi nghiên cứu, ghi động từ mạnh nhất mà thiết kế của nó cho phép.

> **Chọn trong:** được ghi nhận ở (was observed in) · có liên quan với (is associated with) · có thể góp phần vào (may contribute to) · đã làm giảm / không làm giảm (reduced / did not reduce) · gây ra (causes)

#	Nghiên cứu	Động từ mạnh nhất mà vẫn trung thực
a	Loạt ca bệnh gồm 12 người bệnh ICU bị sốc nhiễm khuẩn có phù phổi sau khi truyền lượng dịch lớn	
b	Nghiên cứu thuần tập trên 3,000 người bệnh sepsis: cân bằng dịch dương và tử vong, có hiệu chỉnh theo mức độ nặng	
c	Một thử nghiệm ngẫu nhiên đơn lẻ trên 48 người bệnh: quy trình hạn chế dịch và cân bằng dịch ngày 5	
d	Năm thử nghiệm ngẫu nhiên lớn và một phân tích gộp, tất cả đều nhất quán	
e	Khảo sát cắt ngang về mức độ đầy đủ của phiếu theo dõi cân bằng dịch tại hai ICU	

A3. Viết câu kết quả (con số + khoảng tin cậy, không dùng tính từ)

Viết một câu cho mỗi kết quả, theo mẫu "Ở [ai], [kết cục] [tác động] ([chỉ số] [giá trị], khoảng tin cậy 95% [giới hạn dưới] đến [giới hạn trên])".

1. Bài báo 2, thuần tập ngày 3: tử vong 28 ngày, cân bằng dịch dương so với âm, HR 1.56, khoảng tin cậy 95% 1.10 đến 2.22, P = 0.012.
2. Bài báo 1: tử vong trước ngày 28, 6/24 (hạn chế dịch) so với 6/24 (nhóm chứng), nguy cơ tương đối 1.0, khoảng tin cậy 95% 0.38 đến 2.66.
3. Bài báo 2, thuần tập ngày 1: HR 1.17, khoảng tin cậy 95% 0.85 đến 1.60, P = 0.354.

A4. Tên đề tài từ PICO của bạn

Công thức: **[Thiết kế] về [Can thiệp / phơi nhiễm] so với [Nhóm so sánh] ở [Đối tượng]: tác động lên / mối liên quan với [Kết cục]**. 10–16 từ, nêu rõ thiết kế, không dùng "impact" (tác động), "novel" (mới), "first" (đầu tiên).

PICO của tôi: P _____ I/E _____ C _____ O _____

Tên đề tài tạm thời: _____

Số từ: ____ Đã nêu thiết kế? ☐ Động từ chừng mực (mối liên quan cho thiết kế quan sát)? ☐

Phần B: Thực hành bản thảo 2: hoàn thiện phần Kết quả cho câu hỏi của bạn

Nhiệm vụ. Trong toàn bộ thời gian thực hành, làm việc trên **phần Kết quả cho câu hỏi bạn đã chọn** (Q1 đến Q5), với bản nháp của bạn từ Buổi 7 và gói kết quả của bạn. Trước tiên, áp dụng năm bước kiểm tra bên dưới cho bản nháp và ghi từng lỗi kèm cách sửa. Dòng đầu tiên là một ví dụ mẫu

của Q1. Sau đó dùng thời gian còn lại để sửa lỗi và viết những phần còn thiếu, để phần Kết quả báo cáo mọi kết quả trong gói. Khi gặp khó khăn, hỏi giảng viên trong khung chat. Sau buổi học, hoàn thiện bản nháp và gửi email trước 23:59 Chủ nhật 20/12/2026 (xem "Gửi gì, gửi cho ai").

Năm bước kiểm tra

1. **Con số:** mọi con số khớp với gói kết quả của bạn. Tỷ lệ phần trăm có mẫu số và ước lượng có khoảng tin cậy 95%.
2. **Tính đầy đủ:** mọi bảng và hình trong gói đều có trong bản nháp và được nhắc đến trong phần lời, và mọi ước lượng trong đó đều được báo cáo. Có cả ước lượng thô và đã hiệu chỉnh.
3. **Bảng và hình:** tên, đơn vị, n và chữ viết tắt. Mỗi bảng, hình tự đọc hiểu được mà không cần văn bản.
4. **Từ ngữ:** không diễn giải, không "xu hướng", không động từ nhân quả.
5. **Tên bài dự kiến:** 10–16 từ, nêu thiết kế, dùng "có liên quan" cho thiết kế quan sát.

Bản nháp phần Kết quả của tôi

Bước kiểm tra	Lỗi tôi tìm thấy	Cách tôi sửa
Ví dụ (Q1)	"35.9% tử vong ở nhóm cân bằng dịch dương" không có mẫu số	"134 trên 373 người bệnh (35.9%) có cân bằng dịch dương đã tử vong (Bảng 2)"
Con số		
Tính đầy đủ		
Bảng và hình		
Từ ngữ		

Tên bài dự kiến của tôi:

_____

Kiểm tra lần cuối trước khi gửi

- ☐ Mọi con số khớp với gói kết quả
- ☐ Tỷ lệ phần trăm có mẫu số, ước lượng có khoảng tin cậy 95%
- ☐ Báo cáo cả ước lượng thô và đã hiệu chỉnh
- ☐ Mọi bảng và hình trong gói đều có mặt, được nhắc đến trong phần lời và tự đọc hiểu được
- ☐ Không diễn giải và không dùng từ nhân quả
- ☐ Tên bài dự kiến và câu công khai sử dụng AI

Các phần khác (học ở 8.1, không bắt buộc nộp)

Nếu có thời gian, thêm bất kỳ phần nào dưới đây vào cùng tệp. Giảng viên sẽ nhận xét.

- **Đặt vấn đề:** ba đoạn: điều đã biết, điều chưa biết, mục tiêu

- **Bàn luận:** trả lời, so sánh (ví dụ với Bài báo 2), giải thích, hạn chế kèm chiều hướng ảnh hưởng, ý nghĩa, kết luận
- **Tóm tắt:** có cấu trúc, không quá 250 từ, số liệu giống hệt phần Kết quả

Gửi gì, gửi cho ai

`Surname_Firstname_Results_QN.docx`, gửi email cho người bình duyệt của bạn và giảng viên Vương Mỹ Lượng (myluong1710@gmail.com) **trước 23:59 Chủ nhật 20/12/2026 (giờ Việt Nam)**. Bài báo cáo tất cả kết quả trong gói của bạn (`Manuscript_Brief_VN.pdf`). Sau đó là bình duyệt (`Peer_Review_Instructions_VN.pdf`): bản bình duyệt của bạn nộp thứ Tư 30/12/2026, phần Kết quả đã sửa và thư phản hồi (`Response_to_Reviewers_Template_VN.docx`) nộp thứ Bảy 9/1/2027.

Phần C: Công bố (bài về nhà)

Nhiệm vụ. Tự làm C1 và C2 ở nhà và ghi câu trả lời vào chỗ trống. Đáp án có trong phiếu đáp án, gửi sau buổi học.

C1. Nhận diện tạp chí săn mồi

1. Tìm các dấu hiệu cảnh báo trong thư mời (hư cấu) dưới đây. Bạn tìm được bao nhiêu? (Thư được giữ nguyên tiếng Anh, vì thư mời loại này thường viết bằng tiếng Anh.)

> **From:** editorial.board.gjcmr@freemail.com
>
> **Subject:** Invitation to publish in our esteemed journal!!
>
> Dear Respected Professor/Doctor,
>
> Greetings! We have gone through your excellent article and are delighted to invite you to submit to the *Global Journal of Clinical Medicine, Nursing, Engineering and Management Research*. We publish all areas of science.
>
> Our journal has an Impact Factor of 9.2 (International Universal Index). We guarantee peer review within 48 hours and publication in 5 days. Processing charges will be communicated after acceptance. Special discount this week only!
>
> Kindly submit your manuscript by replying to this e-mail.

Các dấu hiệu tôi tìm thấy:

_____

2. Bạn sẽ tin tạp chí nào? Với mỗi hồ sơ tạp chí (hư cấu), ghi *Tin cậy / Kiểm tra thêm / Tránh* và một lý do.

Hồ sơ tạp chí	Nhận định của bạn	Lý do
J1: Được chỉ mục trong MEDLINE (đã xác nhận trên NLM Catalog), tên biên tập viên kiểm chứng được tại các trường đại học, phí (APC) công bố trên website, thời gian trung vị đến quyết định đầu tiên 9 tuần, dùng bảng kiểm CONSORT/STROBE.		
J2: Tự giới thiệu "indexed in Google Scholar and Index Copernicus", hứa chấp nhận trong 72 giờ, không có thông tin về phí, ảnh ban biên tập không kèm cơ quan công tác.		
J3: Truy cập mở, có trong danh sách DOAJ, tạp chí nhỏ của một hội chuyên ngành, chưa có hệ số ảnh hưởng, chính sách bình duyệt và rút bài rõ ràng.		
J4: Tên chỉ khác một từ so với một tạp chí nổi tiếng. Địa chỉ website khác với website của tạp chí thật. Tạp chí email cho bạn trước.		

3. Ba bước kiểm tra bạn luôn làm được: danh sách kiểm tra Think.Check.Submit · DOAJ (Directory of Open Access Journals) · NLM Catalog ("currently indexed in MEDLINE"). Bạn cũng có thể hỏi cán bộ thư viện.

C2. Phản hồi ý kiến phản biện

Hãy tưởng tượng nghiên cứu bạn đề xuất đã hoàn thành và đã gửi đăng. Viết một dòng phản hồi cho mỗi nhận xét (cảm ơn, trả lời, nói chính xác điều gì đã thay đổi). Một trong số đó cần được phản bác một cách lịch sự.

#	Nhận xét của người phản biện	Phản hồi của chúng tôi	Thay đổi đã thực hiện (trang, dòng)
R1.1	"Tiêu đề nói can thiệp của bạn *cải thiện* kết cục, nhưng đây là nghiên cứu quan sát."		
R1.2	"Đề nghị báo cáo kết quả chính kèm khoảng tin cậy, không chỉ giá trị p."		
R1.3	"Phần văn bản và Bảng 2 đưa ra số người bệnh được phân tích khác nhau (212 so với 208)."		
R2.1	"Đề nghị bổ sung tử vong 1 năm." (Đề cương của bạn chỉ theo dõi người bệnh đến ngày 28.)		

Danh sách kiểm tra giọng văn: ☐ đã cảm ơn người phản biện ☐ đã trả lời mọi ý ☐ đã nói bản thảo thay đổi ở đâu ☐ chỉ phản bác khi có bằng chứng, một cách lịch sự

Phần D: Làm người phản biện (phiếu trả lời)

Nhiệm vụ. Trong buổi học, tự thẩm định cả hai bài báo (6 phút). Với Bài báo 1, trả lời câu 4, 5, 7, 8 và 9. Với Bài báo 2, trả lời câu 4, 5, 8 và 9. Với mỗi câu, đánh dấu Có, Không hoặc Không rõ, ghi số trang và thêm một dòng ghi chú. Bảng "Tìm ở đâu" cho bạn biết số trang. Chuẩn bị chia sẻ câu trả lời khi giảng viên mời. Ở nhà, trả lời các câu còn lại (1–3, 6 và 10) cho cả hai bài báo.

"Không rõ" là câu trả lời tốt khi bài báo không nói đến.

	Bài báo	Thiết kế
Bài báo 1	Boulet N, et al. *Crit Care* 2024;28:429 (chiến lược hạn chế dịch không nhằm hồi sức, OPTIFLUID)	Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng thí điểm, 48 người bệnh được phân tích
Bài báo 2	Hyun D-G, et al. *Ann Intensive Care* 2023;13:105 (cân bằng dịch tích lũy dương trong ba ngày ICU đầu tiên)	Nghiên cứu thuần tập ghép cặp theo điểm xu hướng từ một hệ thống lưu trữ dữ liệu (registry) về sepsis, 2516 người bệnh

Số trang là số trang của tạp chí, in ở đầu mỗi trang ("Page X of 13" với Bài báo 1, "Page X of 9" với Bài báo 2). Dùng bản PDF gốc (không có chú thích).

Tìm ở đâu

Câu hỏi	Bài báo 1 (RCT): trang	Bài báo 2 (thuần tập): trang
1 Câu hỏi	Tóm tắt (tr.1), đoạn cuối phần Background (tr.3)	Tóm tắt (tr.1), cuối phần Background (tr.2)
2 Thiết kế	Tiêu đề (tr.1), "Trial design and oversight" (tr.3)	Tiêu đề (tr.1), Methods (tr.2–3)
3 Người tham gia	"Patients" (tr.3), sơ đồ Fig. 1 (tr.5), phần hạn chế trong Discussion (tr.10)	"Data source and patient selection" (tr.2), đoạn đầu phần Results (tr.3)
4 Nhóm so sánh	"Randomization and blinding" (tr.3), Table 1 (tr.6)	"Propensity score matching" (tr.2–3), Table 1 (tr.5–6), văn bản tr.4
5 Sai lệch	"Randomization and blinding" (tr.3), Discussion (tr.8)	Methods (tr.2–3), phần hạn chế trong Discussion (tr.7–8)
6 Kết cục	"Outcomes" (tr.4)	"Propensity score matching and outcomes" (tr.3)
7 Số liệu	"Primary outcome" (tr.6), Table 3 (tr.10)	Tóm tắt (tr.1), "Outcomes" (tr.4)
8 Lời lẽ so với thiết kế	Kết luận trong tóm tắt (tr.1), Discussion (tr.8, 10), Conclusions (tr.11)	Tiêu đề (tr.1), kết luận trong tóm tắt (tr.1), Discussion (tr.4, 7), Conclusions (tr.8)
9 Hạn chế	Discussion (tr.8–10)	Discussion (tr.7–8)
10 Ứng dụng	Nhận định của bạn (toàn bài)	Nhận định của bạn (toàn bài)

Phiếu trả lời (mỗi bài báo một bản)

Bài báo: 1 / 2

#	Câu hỏi (bảng kiểm thẩm định rút gọn)	Có	Không	Không rõ	Trang	Ghi chú (một dòng)
1	**Câu hỏi**: Bạn có viết được PICO của nghiên cứu trong một dòng không?	☐	☐	☐		P: … I/E: … C: … O: …
2	**Thiết kế**: Thiết kế là gì, và có phù hợp với câu hỏi không?	☐	☐	☐		
3	**Người tham gia**: Ai được đưa vào, và ai bị bỏ ra ngoài? Người bệnh của bạn có được đưa vào không?	☐	☐	☐		
4	**Nhóm so sánh**: Các nhóm có giống nhau lúc ban đầu không (Bảng 1)? Điều đó đạt được bằng cách nào (phân bổ ngẫu nhiên / ghép cặp / hiệu chỉnh)?	☐	☐	☐		
5	**Sai lệch**: Ai biết người bệnh thuộc nhóm nào (làm mù)? Điều đó có thể làm thay đổi kết cục không?	☐	☐	☐		
6	**Kết cục**: Có MỘT kết cục chính được xác định trước, đo giống nhau ở cả hai nhóm không?	☐	☐	☐		
7	**Số liệu**: Kết quả chính dưới dạng độ lớn tác động kèm khoảng tin cậy 95% là gì? Khoảng tin cậy hẹp hay rộng?	☐	☐	☐		Tác động: …… Khoảng tin cậy 95%: ……
8	**Lời lẽ so với thiết kế**: Kết luận có tương xứng với thiết kế không ("có liên quan" so với "gây ra", không dùng "xu hướng" cho p = 0.42)?	☐	☐	☐		Từ tìm thấy:
9	**Hạn chế**: Các hạn chế chính có được nêu trung thực không? Nêu một hạn chế tác giả bỏ sót.	☐	☐	☐		Bỏ sót:
10	**Ứng dụng**: Bài báo này có làm thay đổi thực hành tại khoa của bạn không? Vì sao có / vì sao không?	☐	☐	☐		

Nhận định của tôi trong một câu: _____

Một điều tôi sẽ đưa vào đề cương của mình: _____

Gợi ý nếu bạn bị bí

- **Câu 1:** PICO thường nằm ở đoạn cuối phần Đặt vấn đề ("we aimed to …"). Kết cục của bài báo có giống câu hỏi xuyên suốt (tử vong 28 ngày) không?
- **Câu 4:** thử nghiệm ngẫu nhiên làm các nhóm giống nhau nhờ may rủi. Nghiên cứu thuần tập chỉ có thể ghép cặp hoặc hiệu chỉnh theo những gì đã được đo. Tìm câu văn nói rõ bài báo dùng cách nào.
- **Câu 5:** ai quyết định lượng dịch mỗi người bệnh nhận được, và họ có biết nhóm không?
- **Câu 7:** tìm chữ "difference" hoặc "HR" theo sau là dấu ngoặc. Khoảng tin cậy có chứa 0 (với hiệu số) hoặc 1 (với tỷ số) không?
- **Câu 8:** tìm các từ *impact, show, trend, ever, regardless*.